

“十五五”时期农村人口老龄化健康安全风险的演化机理与前瞻治理[※]

内容提要：“十五五”时期，中国农村将迈入超级老龄化社会，面临系统性人口健康安全风险。基于“系统脱嵌—风险生成—韧性再嵌”动态分析框架，研究发现农村健康服务体系面临健康服务供需失衡的制度脱嵌、基层健康支持网络弱化的组织脱嵌、“城乡倒置”与健康人力资源高度短缺的资源脱嵌、健康治理现代化乡土失配的技术脱嵌和现代健康治理理念悬浮的认知脱嵌，会导致老年群体复合健康损失与失能增多、卫生系统结构性失效、照护网络及公共安全承载力超载与发展韧性侵蚀等多重风险显化与递进发展。建议未来以“韧性嵌入”为治理导向，通过双向认知调适与制度情境化嵌入的理念重塑、协同治理的整合型政策体系完善、内外联动的在地化服务网络重建、乡土包容性数字赋能的服务发展和跨路径风险防控的动态调适机制构建，形成可及、可负担、且可持续的农村健康治理体系。

关键词：农村 超级老龄化 健康安全风险 系统脱嵌 韧性治理

中图分类号：F323.89;R161.7

文献标识码：A

文章编号：1009—2382(2026)05—0122—11

一、引言

随着中国人口老龄化进程的持续加速，农村地区正率先进入“超级老龄化”阶段。根据第七次全国人口普查数据计算，中国 57.96% 的老人居住在农村，农村地区 60 岁及以上老年人口比重已经达到 23.81%，人口老龄化程度高出城镇地区 7.99 个百分点。根据石人炳和虎经博(2024)等学者的预测，农村人口老龄化已从温和增长进入加速区间，仅需 15 年农村老年人口将突破 1.5 亿，人口老龄化水平年均增长超过 1 个百分点。高龄、失能、空巢老人规模持续扩大，传统以家庭为核心的非正式照护体系日渐式微，而城乡二元结构下的公共服务供给失衡，进一步加剧了农村老年人口健康支持的脆弱性。与此同时，国家战略与政策环境正在发生积极变化。在《国家积极应对人口老龄化中长期规划》和《“健康中国 2030”规划纲要》的战略引导下，农村老年人口健康服务体系建设正发

生深刻转型：从既往以“疾病治疗”为中心，逐步转向涵盖“预防保健、慢性病管理、失能照护、心理关爱”等多维度的综合健康保障体系。这一转变不仅对基层医疗卫生服务能力提出了更高要求，也对现有养老保障、社区服务、数字接入、社会参与等系统的协同能力形成严峻考验，老年人口健康安全及其应对已日益凸显为影响乡村振兴与城乡融合发展的关键变量。而县域医共体发展、长期护理保险试点、数字乡村建设等政策举措，为农村老年健康服务体系建设提供了新的制度窗口与技术可能。然而，政策红利如何真正转化为农村老年人的健康获得感，仍面临系统性障碍：农村健康治理体系在制度设计、组织运作、资源配置、技术应用与健康认知等维度均存在不同程度的系统脱嵌，导致服务供给与现今的乡土社会实际需求之间出现结构性错配，进而增加人口健康安全风险。

在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中，一方面指出“农业农村现代

[※] 基金项目：国家社会科学基金项目“延迟退休背景下健康促进型中老年职业流动支持体系研究”(编号：25BRK016)；江苏省哲学社会科学基金项目“江苏‘三明治’老人双向代际支持研究”(编号：24SHB010)。

化相对滞后”“人口结构变化给经济发展、社会治理等提出新课题”等发展环境的复杂变化,另一方面也提出了“加快建设健康中国”和“促进人口高质量发展”,以扎实推进全体人民共同富裕。这为“十五五”时期积极主动应对农村人口老龄化带来的健康安全风险提供了根本遵循和基本要求,也带来了问题应对的重要契机。但是,回顾国内近年老龄化社会健康治理议题的研究,主要围绕范式变革与治理理念、高质量发展与服务体系优化、数字技术赋能三方面进行。江生忠等(2024)认为老龄社会以老年人健康问题为核心,给人口和社会可持续发展带来高度不确定性、损失性和复杂性的多维风险,具有基础性、系统性和全人群全周期性等特点。学者们强调健康老龄化理念的深化与拓展,提出构建覆盖全生命周期的“主动健康治理”中国方案(彭希哲, 2025)和融入国家人口高质量发展战略的积极健康老龄化(薛文忠等, 2022)。研究较为关注服务体系的提质增效与均衡可及,认为当前的资源配置存在结构性失衡(刘慧君和吴鹏, 2025; 庞瑞芝和李倩楠, 2024)。数字技术被视为推动健康老龄化的重要引擎(陈华帅和马伟, 2024),但其带来的数字鸿沟问题也备受关注,强调技术发展必须兼顾包容性(谢永飞和刘铁锋, 2024),指出社区健康传播是弥合数字鸿沟、赋能老年健康的关键路径(陈柏霖, 2022)。尽管既有研究已经从社会治理的视角,基于积极老龄化和健康老龄化的理念对中国人口老龄化健康风险进行了分析,并给出本土化的方案与建议,但学者对健康专业服务资源明显薄弱,老龄化程度更深,且“十五五”时期即将快速迈入超级老龄化的农村地区缺少专门性关注,尚未能充分揭示未来五年和更长的时间里,人口老龄化与健康资源严重倒挂的农村可能面对的健康风险及其可能引发的系列社会风险,更未能基于农村地区的现实条件提出专门性治理策略。

为此,本研究聚焦“十五五”时期中国农村人口老龄化健康安全风险的演化机理与治理路径,核心关切在于:如何从嵌入理论的视角,揭示“十五五”时期农村老年健康服务体系中制度、组织、资源、技术和认知等多重脱嵌形态及其风险演化,又如何通过“韧性再嵌”的逻辑,在乡土适配与城乡融合的双重导向下,构

建可及、可负担、且可持续的健康治理体系。研究试图在理论层面丰富嵌入理论在健康治理领域的应用,在实践层面为“十五五”时期农村健康老龄化政策提供前瞻性建议,助力实现农村社会从“应对老龄化”到“积极老龄化”的健康治理范式转型。

二、人口健康安全及其风险表征

1. 人口健康安全的概念与内涵

人口安全是一个本土化的概念,其形成是人口学与国家安全理论交叉融合的产物。随着全球化进程加速与非传统安全议题凸显,人口问题不再局限于规模、结构等传统维度,而是日益与国家发展的稳定性、可持续性和韧性紧密相连。学界逐步超越将人口仅视为“资源”或“负担”的工具性视角,转而从系统性风险与整体安全的高度进行重构。2003年的“人口、社会与SARS”专题研讨会上,时任国家人口和计划生育委员会主任张维庆首次提出了这一概念。其后,对国家人口问题与人口风险的研判、国家人口安全体系的建设,再次成为引发理论思考的学术焦点(原新等, 2025)。多数学者将人口问题与国家安全、社会稳定结合在一起阐述人口安全问题(陈功等, 2005)。其中,翟振武和明艳(2005)指出人口安全的核心在于维持人口自身要素(数量、结构、素质)的适度规模与内部均衡,避免失衡威胁国家可持续发展,这一理解更为全面地体现了两个时期学者们讨论中所强调的人口安全核心要素。可以看出,从人口安全这一本土化概念的提出到其后的理论释义,人口健康作为支撑人口长期均衡发展与国家可持续发展的核心要素,在人口安全整体框架下,日益凸显独立的理论价值和政策意义。相较于传统的公共卫生视角多聚焦于如何以疾病防控应对健康问题,人口健康安全将健康置于人口安全体系中进行审视,以更为系统、动态和前瞻的视角提出健康治理范式。本研究基于中国人口安全提出的历史背景和当前中国对于安全问题的核心关切,将人口健康安全界定为:在人口发展过程中,人口健康素质所面临的系统性风险,以及社会为预防、应对和适应此类风险所具备的防护与恢复能力。人口健康安全是人口安全在健康维度的具体化,强调健康不仅是个人福祉,更是国家稳定与社会发展的重要战略资本。

人口健康安全的内涵包括三个层面:一是生命存续的底线健康安全,涉及粮食安全、清洁饮水、基本医疗卫生服务等保障人口生存的基础条件;二是健康素质的结构性安全,关注传染病与慢性病双重负担、精神健康、妇幼健康、老年健康等群体性健康风险的分布与演变,强调不同群体(如儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者)的健康风险分布与健康公平问题;三是健康与发展的协同安全,强调健康与教育、就业、环境、社会保障等系统的相互影响,以及人口健康对社会稳定、经济发展和国家韧性的支撑作用。提出“人口健康安全”这一概念,旨在推动人口健康治理从个体和疾病视角,转向群体和健康视角,从被动应对转向主动预警与韧性建构,从而在人口高质量发展与中国式现代化进程中,构建更具整合性、前瞻性和包容性的健康治理体系。

2. “十五五”时期的人口健康安全风险表征

基于前文提出的人口健康安全概念和内涵理解,分析“十五五”时期,农村人口老龄化快速发展与迈入超级老龄化社会主要带来的人口健康安全风险有:

一是群体健康风险:复合健康损失与失能增多。根据《第五届中国城乡老年人生活状况抽样调查基本数据公报》显示,农村老年人高血压占 41.6%,患腰椎间盘突出占 23.1%,患关节炎占 22.1%。自评健康状况为非常好和比较好的仅占 38.7%。城镇老人不仅健康预期寿命显著长于农村老人,而且失能后的预期寿命也显著长于农村老人(李逸超和米红, 2025)。随着预期寿命的不断延长,更多农村老年个体不仅面临更为严峻的身心功能衰退,认知障碍、营养不良、肌少症、跌倒及抑郁焦虑等综合征高发,心血管疾病、代谢性疾病、骨关节疾病等慢性病相互叠加,严重损害个体生活质量与自主性,形成复杂的非单一病态健康状态,失能半失能的发生率显著提升,中重度失能比例显著高于城镇(浦雪和翟铁民, 2025)。

二是卫生系统风险:需求激增与结构性失效。老年综合症、失能、多病共患的数量激增,需要农村卫生服务系统有更强、更多的老年慢性病管理、康复护理、长期照护的专业能力与资源,中重度老龄化社会也带来了卫生人力、设施和支出的结构性转变和数量的激增(周建芳等, 2024;许昕等, 2025)。这会使得卫生

人力、财力和物力都紧缺的农村,面临更多方面的资源紧缺,尤其是能够胜任整合性服务的健康管理人才、提升老年功能发挥的康复人才短缺。“十五五”时期,如果继续维持现有的资源规划和服务模式,必将形成“有机构无服务”的结构性功能缺口,不仅不能满足农村老年人的卫生服务需求,国家老年相关的基本公共服务也无法有效落实。

三是照护体系风险:家庭与社会支持网络高位承压。随着空巢、独居和高龄老人的比例激增,在外部支持无法显著增强的情况下,农村将越来越多地出现“以老护老”“以弱护弱”的照护情形,不仅高龄一代的照料面临质量不高的困境,年轻老年人也极有可能因照料压力而形成身心健康的破坏,产生更多的护理服务需求。老年健康照护服务压力还会进一步外溢到养老机构和社区居家养老服务等正式照护资源。老年健康服务体系的断裂一旦发生,会带来更多失能半失能人口,而老人及其家庭的支付能力都无法在短期内快速提升,不能够吸引企业进行养老投资,失能老年人将陷入“家庭无力管、社会无处接”的照护真空状态。

四是社会系统风险:公共安全承载力超载。在传染病疫情、自然灾害等应急情境下,农村老年人因基础疾病多、信息闭塞、转移困难等原因,对于突发事件的应急储备需求原本就大于城市群体,在健康服务体系和照护体系高位承压的情况下,应急需求将被进一步放大,容易出现公共安全承载力显著超载的情形。一旦发生突发事件,特别是突发公共卫生事件,农村家庭因病返贫、基层医疗财政负担加重、村居活力衰退等现象相互激化,老年群体的健康风险将快速传导成为经济社会风险,可能造成农村发展韧性丧失,诱发区域性人口健康安全系统的失序。

总体而言,“十五五”时期的农村老龄化速度加快和规模加大,带来的不仅是人口结构性问题,而且是老年群体的健康风险问题,更是健康治理体系整体性的应力测试。若缺乏系统性干预,这些风险表征将从老年群体层面,外溢到卫生服务和照护体系,并进一步升级为区域性人口安全危机。

三、“系统脱嵌—风险生成—韧性再嵌”动态理论分析框架

为系统阐释农村人口老龄化健康安全风险的演

化机制与治理逻辑,本研究基于嵌入理论,整合风险社会理论以及系统韧性理论,构建“系统脱嵌—风险生成—韧性再嵌”的动态分析框架,旨在超越静态的结构分析,揭示农村健康支持系统与乡土社会生态之间关系断裂、风险显化的现状,并进一步提出韧性重构的治理思路,为“十五五”时期的前瞻治理提供理论参考。

首先,波兰尼的嵌入理论中的“嵌入”与“脱嵌”命题为本研究提供了核心的历史制度主义视角。波兰尼指出,经济并非自足的系统,在前工业社会中,它深深“嵌入”于社会关系、宗教与文化规范之中。现代市场经济的崛起则导致了一场“脱嵌”的伟大变迁,即经济法则试图脱离社会的制约而支配整个社会,这一过程必然引发社会以保护性立法、政策等形式进行的

“反向运动”(波兰尼,2007)。脱嵌作为嵌入的反向延伸,其核心是“嵌入平衡状态的打破”,而非完全脱离嵌入环境。其后,格兰洛维特(2007)从行动者与社会结构互动的关系论视角,对波兰尼的宏观嵌入为主的提法进行了修正,强调了社会关系网络在其中的作用。Zukin 和 DiMaggio(1990)则从政治文化分析的视角,提出政治、文化、认知等多维嵌入,丰富了嵌入的维度。而 Hagedoorn(2006)则进一步从宏观(环境)、中观(组织)和微观(关系)三个层级再次丰富了嵌入理论。近年来,中国学者将这一理论进行了多学科的应用,并根据具体应用领域和对应的问题分析进一步扩大了嵌入维度,特别是技术维度在多领域被广泛分析。表 1 梳理了嵌入理论的主要发展脉络。

表 1 嵌入理论发展脉络

时间	学者	核心贡献	嵌入类型
1944	Polanyi, K.	提出“嵌入性”概念,强调经济嵌入社会	原始(宏观)嵌入
1985	Granovetter, M.	引入社会网络分析	关系嵌入、结构嵌入
1990	Zukin, S. 和 P. DiMaggio	拓展制度嵌入维度	制度嵌入、政治嵌入、文化嵌入、认知嵌入
2006	Hagedoorn, S.	从宏观、中观和微观三个层次论述对企业合作行为的影响	环境嵌入、组织嵌入、双边嵌入
2010 年至今	多学科应用	更多维度的嵌入涌现	技术嵌入、资源嵌入、过程嵌入等

中国农村传统的老年健康支持体系一直高度“嵌入”乡土社会结构与伦理规范之中,但快速现代化与城镇化进程,导致部分传统健康支持体系从乡土社会肌体中剥离的同时,也出现部分现代健康支持被悬置,与当前的农村老年人口、老年家庭及其社区环境呈现脱嵌状态,并与超级人口老龄化结构相耦合,加大人口健康安全风险的发生概率。超级老龄化社会的健康安全风险并非孤立议题,而是制度安排、组织协同、资源配置、技术应用与社会认知多重维度复杂交织作用的演化结果。嵌入理论通过其多维要素的透视,脱嵌与再嵌的动态过程理解,系统揭示健康风险演化机理,并为探索系统的韧性治理路径提供了兼具解释力与建构性的理论工具。为此,本研究将这一理论应用于公共健康治理领域,基于农村现实,侧重

从制度、组织、资源、技术和认知五个维度,分析导致产生农村社会人口健康安全风险的系统脱嵌成因,探讨风险消减的韧性再嵌机制。其中,制度嵌入指正式的规则体系对老龄健康相关实践的结构性塑造与约束过程;组织嵌入指政府、社区、医疗机构、养老机构、社会组织及家庭等多元行动主体,在应对老龄化健康风险过程中所形成的相对稳定的网络关系、位置结构及其互动模式;资源嵌入指健康相关的物质、人力、财力与社会资本等资源,在社会关系与组织结构中的流动、整合、配置与获取过程;技术嵌入指信息技术、智能设备、数字平台等工具在老龄健康服务与管理中的应用;认知嵌入指社会文化背景、历史经验、集体记忆与价值观念对老龄化、健康、风险及照护等相关议题的意义建构、知识生产与感知判断所产生的深层影

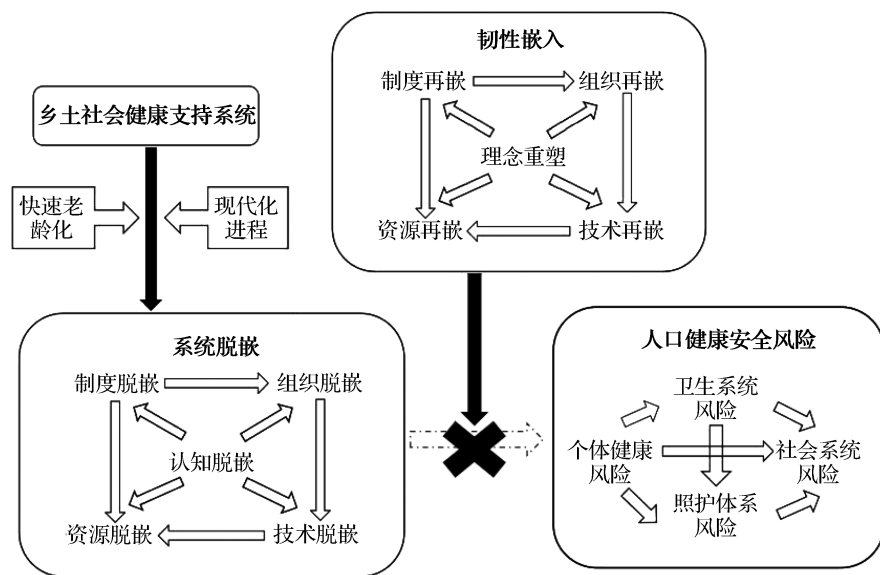


图1 理论分析框架

响。制度为组织互动提供规则,组织是资源配置与技术应用的载体,技术重塑资源流动与组织关系,而认知则渗透并影响所有层面的实践逻辑及其作用效果。五个维度相互关联、彼此嵌入,共同构成分析超级老龄化社会健康风险的系统性框架。

其次,贝克的风险社会理论为理解“脱嵌”后果提供了关键透镜。1986年,贝克首次提出了“风险社会”的概念,此后随着学者们不断地研究与完善,风险社会理论已成为诠释和治理现代风险的重要理论,强调现代社会的风险源于科技的应用,并可能转化为制度性风险(吕佩安,2025)。科技的发展与应用,使得健康威胁不再仅仅是自然的、个体的生理事件,而演变为由制度缺陷、组织失灵、资源错配、技术壁垒与认知偏差等社会过程所共同建构的系统性群体风险。借鉴制度主义风险社会进路,本框架尤其关注风险如何通过不完善的制度被制造和分配;同时,风险分析的文化主义视角提示不同群体(如老年人与政策制定者)对同一健康风险可能存在截然不同的认知与叙事,这进一步影响了风险的感知与应对有效性。“十五五”时期,农村的老龄化发展与系统脱嵌的耦合,将高度放大这一风险发生的概率和可能后果,亟须高度重视、风险化解与应对储能。

最后,当代韧性理论,特别是系统韧性理论,为超越被动风险应对、转向主动系统重建指明了方向。系

统韧性理论强调社会生态系统在遭受极端冲击时,能够通过防御力(事前)、恢复力(事中/后)与适应力(持续)的综合作用,维持核心功能并实现转型发展的能力(詹承豫等,2022)。这为本研究的“再嵌”概念注入了动态、主动与发展的核心内涵。面向“十五五”及未来的健康治理,不能是简单的“回归”传统或对现有系统的“修补”,需要推动“韧性再嵌入”。新建构的健康支持系统需要广泛吸纳各方参与,具备对乡土复杂性的高度适应力、在压力下的功能存续与恢复力,以及利用冲击进行创造性重组与学习的主动吸纳能力,从而实现从静态表征到动态平衡的转变,最终形成一个能扎根乡土、抵御扰动并实现可持续发展的韧性治理结构。

为此,融合上述理论洞见,本研究提出如图1所示的理论分析框架。该框架采用长时序视角,将“十五五”时期置于系统动态演化的关键节点,展示了从“脱嵌”到“风险”再到“再嵌”的因果链条与治理干预的窗口期。

四、农村人口老龄化健康安全风险演化机理

在城市化与效率优先的发展逻辑下,原本深度嵌入乡土社会结构、乡土文化与日常生活实践中的农村健康支持体系逐渐脱嵌与失效。在老龄化程度尚浅时,这种脱嵌后果可能被健康网络韧性所缓冲。然而,当农村快速迈向超级老龄化时,多维脱嵌不仅被

充分暴露,更可能会形成“制度偏差削弱组织—组织弱化消耗资源—资源错配导向技术—技术隔离固化认知”的负向风险递进与放大,同时,先进的健康老龄化治理理念与农村老年群体传统健康认知与行为之间的鸿沟,使得部分政策干预在农村社会“悬浮”,负向健康风险的系统性生产与放大可能性加剧。“十五五”时期,中国农村面临的超级老龄化健康安全风险,其本质是快速现代化进程中社会支持的系统性脱嵌及其与超常规老龄化进程所产生的压力共振。

1. 制度脱嵌:政策适配不足引致健康服务供需失衡风险

制度脱嵌的核心,在于部分健康治理制度无法响应农村人口结构快速演进所引发的动态、复杂性需求。经济合作与发展组织国家的经验表明,当老龄化水平跨越特定门槛时,卫生支出结构及对人力、物力资源的需求会发生非线性跃升(周建芳等,2024)。中国农村在“十五五”期间将急速穿越超级老龄化门槛,但当前卫生资源的配置仍是按照总人口或既有服务利用情况的线性配置法,缺少基于不同老龄化阶段发展需求的资源前置性规划和差异化配置。与此同时,现行制度供给在应对老龄化的需求方面也存在严重的时滞与错配,其突出矛盾有三:一是支付型制度失衡。目前的长期护理保险大试点多在城镇地区,未能有效覆盖农村地区,而农村的超级老龄化和高龄化发展,必然伴随较城市更为严峻的失能率陡增,导致家庭陷入“照护贫困”与财务危机(江生忠等,2024)。二是保障型制度错配。基本医保重点保住院,对门诊慢性病管理和保障不足,难以应对农村普遍增加的多病共患、需长期服药和功能康复需求。三是统筹型制度缺位。基于户籍的老年健康管理、失能照护、紧急援助等基本公共服务,不能充分满足越来越多的旅居养老、随子女异地居住等流入地服务需求,城乡医养资源分割难以实现资源的跨区域融合利用。而医养结合的发展也存在养老机构办医的政策性支持不足、公办医疗机构办养老的制度突破难、医疗保障和养老保障制度体系融合不足等问题,农村失能/半失能和患病老人医养结合服务的可及性更低。制度体系的结构性脱嵌,使得老龄化最严峻的农村地区处于社会保障网的边缘,并加剧了城乡老年健康服务供给的不

平等问题。

2. 组织脱嵌:基层正式和非正式健康支持网络双重弱化

组织脱嵌表现为乡土社会正式健康支持组织(乡镇卫生院、村卫生室等初级卫生保健网络)与“家庭—宗族—邻里”的非正式支持网络的共时性弱化。根据国家统计局数据,近十年来,中国乡镇卫生院和村卫生室的数量在持续减少,已经分别从2005年的36817个和640536个,减少到2024年的33334个和570410个,农村基层卫生网络持续稀疏化,专业健康服务半径增加和服务可及性下降,无法承接老龄化发展带来的需求激增。随着城镇化的发展,行政村和行政乡镇数量也在持续减少中,而中国绝大多数公共服务机构的建设是与行政区域相匹配的,意味着农村老年人口的基本公共服务网络半径普遍性扩大,难以通过替代性服务弥补或缓冲健康服务网底疏化带来的风险,且更易形成服务的真空地带。而市场化组织,如居家养老组织、专业健康管理机构等则因规模不经济和消费预期不看好等原因,在农村地区更是普遍缺位。在非正式支持方面,农村社会普遍性的家庭小型化和青壮年外流,不仅家庭内部对于老年人的支持减少,还因人口稀疏和活力下降带来了农村社会网络的空心化,村级自组织活动减少,老人们日常交往对象的数量和可及性也在下降。随着人口结构的进一步老化,“十五五”时期,农村老人更易陷入“原子化”生存状态,成为老年抑郁、认知衰退及突发健康事件后不良结局的独立危险因素(李静和王小凤,2025)。社会联系的稀薄不仅带来心理孤独,更意味着健康风险失去了最直接、最及时的基层缓冲,极易直接演变为家庭灾难。组织脱嵌放大了老年健康风险的破坏力,也凸显了在治理进路中重建乡土互助网络与培育村居内生性健康支持组织的紧迫性。

3. 资源脱嵌:“城乡倒置”与健康人力资源高度短缺

既有人口老龄化与卫生支出的研究表明,人口老龄化并不是卫生支出增长的关键驱动力,其中关键因素在于基层卫生资源和整合性卫生资源的投入情况(Jonathan等,2019)。为实现健康老龄化,中国近年来已经加大了康复和照护资源的投入,老年医院和老

年病科的建设也被列入民生工程。但是,这些资源同样主要分布在城市,对于农村而言,康复护理床位、延续性照护服务、适老化环境改造等整合性资源仍然极度匮乏。更严重的是,由于居住分散,资源配置的空间失配问题被放大,可及性更低。卫生资源中,健康人力资源长期高度紧缺与城乡失衡状态更为突出,根据国家统计局数据,2024年每万人拥有农村卫生技术人员数、每万人拥有农村执业(助理)医师数和每万人拥有农村注册护士数分别为74人、29人和32人,而城市的对应数据则分别为114人、44人和53人,考虑到农村的人口居住密度较低而产生的更高的资源需求,基本公共服务资源的短缺和失衡问题更为突出。而在新中国成立之初便从制度与结构深深嵌入乡土社会的“赤脚医生”队伍,在经历了改革开放初期的市场经济向医疗卫生领域的扩张和21世纪以来基层医疗卫生的公益属性强化后,正面临因收入降低、职业认同感降低而引力不足和自主嵌入积极性不高的发展瓶颈(张雨薇等,2020)。人口老龄化程度与健康资源的空间密度形成了典型的“城乡倒置”现象(原新和范文清,2024)。在专业健康资源的缺口越来越大时,家庭的非正式健康支持力量也逐渐物理上远离老年人的日常生活空间,在老龄化与青壮年外流的双重冲击下,农村空巢、独居老人已成为普遍形态,根据国家统计局普查数据计算,2020年全国人口普查时点,与子女同住老人仅占36.11%。这不仅是老年人照护资源的缺失与成本增加,更是老年家庭内部非正式健康支持系统的高度弱化。

4. 技术脱嵌:数字鸿沟导致健康治理现代化的乡土适配不足

技术脱嵌是现代化进程中产生的老年健康的新壁垒。“十四五”时期,中国在互联网+医疗健康、AI辅助诊疗和可穿戴智能健康监测设备使用等方面取得了长足的进步,数智技术已经逐渐成为提升健康治理效率的核心工具。但是,当前的农村高龄群体仍面临数字鸿沟、使用习惯与文化信任的羁绊,总体呈现技术脱嵌状态。尽管国家层面推动宽带普及,但农村地区,尤其是西部地区,仍普遍存在网络覆盖薄弱、信号不稳定和资费高昂等问题。基于中国家庭追踪调查(CFPS)的数据分析,农村家庭接入高速互联网的

概率比城市低37.6%,且智能手机拥有率和终端设备更新速度显著滞后(Wan等,2026)。物理性接入障碍直接限制了居民使用远程问诊、电子处方、健康档案查询等数字健康服务的能力,这一问题在农村老年群体中更为突出。一项中国城乡老年人的比较研究指出,农村老年用户的数字技能指数平均仅为城市同龄人的58%(Zhang等,2025)。数字鸿沟不仅体现在操作层面,更反映在对在线医疗等智慧化服务的信任缺失与心理抗拒上。许多农村高龄老人不具备智能手机操作技能,对虚拟的在线问诊、电子支付无从知晓或心存疑虑,免费发放的智能手环常因看不懂或不会充电而闲置。数字化福利非但没有成为桥梁,反而因其应用前提与现实脱节,成为将最需要关怀的老年群体隔离在社会福利之外的新壁垒,固化并加剧健康不平等风险。

5. 认知脱嵌:现代健康治理理念悬浮产生健康实践响应困局

认知脱嵌体现在两个相互关联又冲突的层面,共同导致现代健康治理举措在农村“悬浮”。一是现代健康治理理念的传导脱节。国家层面积极倡导的“以健康为中心”“预防为主、医养结合”的先进理念,在向农村基层传导时发生衰减与变形。基层政府与服务机构在资源有限、考核压力下,往往更侧重于完成硬性指标(如建档率、老年健康管理中的体检率),而难以将理念转化为持续、贴心、符合农村老人生活习惯的健康促进与慢性病管理服务,导致先进理念在“最后一公里”被悬置。二是农村老年人健康认知的双重困境。农村老年人的健康认知深植于传统乡土经验、有限信息渠道与现实生存逻辑之中。一方面,传统健康观念与现代健康行为模式出现“认知脱嵌”,仍深植于“小病拖、大病扛”“重治疗轻预防”的经验性认知中,对定期体检、慢性病规范管理、主动康复等现代健康理念接受不足,其健康决策往往脱离基层医疗卫生服务体系的功能设计导向。另一方面,零星传入的“数字健康”“主动健康”等新概念,与其生活经验、文化习惯及现实可及性之间存在的断层,在缺乏家庭成员有效支持的情况下,部分老人出现知晓却无法内化与实践的问题。制度理念的悬浮与老人认知的脱嵌/悬浮相互叠加,使得部分政策干预与健康服务难以

触发老年人的真实需求与主动利用,造成“政府热老人冷”“有政策无响应”的尴尬局面,削弱整体健康支持体系的有效性,使得基层卫生保健网络利用不充分,而二级三级卫生保健网络可及性不高的系统性冲突,加剧老年人在人口结构深度老龄化背景下的健康脆弱性。

“十五五”时期农村超级老龄化的快速进程,为上述五个维度的脱嵌提供了一个高强度、高频率的“压力测试场”。旨在促进健康老龄化的国家政策,在向农村基层传导与落实过程中,因资源配置的城乡二元惯性和对农村社会快速变异性考虑不足,极易产生执行偏差。制度偏差如无法及时得到有效纠偏,会削弱本已脆弱的农村基层卫生与社区组织网络,将直接消耗既有的有限资源效能,导致资源配置出现严重的空间与结构错配。数智技术的健康治理应用,如果不能配以基础设施、使用能力与文化信任的及时跟进,技术应用非但不能赋能,反而在实践中形成对老年群体的新隔离。与此同时,“预防为主、医养结合”的先进健康治理理念,与农村老年人根深蒂固的“治疗为中心”“依赖家庭”的传统认知之间的冲突若不能及时化解,也会陷入制度悬浮状态。多维脱嵌对人口健康安全风险的联动生成机制,使得任何单一维度的干预都难以奏效,如果不能系统性应对,风险将在系统中不断循环放大,最终会外显为可观测的危机结果,加剧老年群体健康服务和健康的不公平风险,并可能进一步演化为农村社会的整体性安全风险。

五、“十五五”时期农村人口老龄化 健康安全风险治理进路

针对“十五五”时期面临的农村因系统脱嵌与超级老龄化耦合引发的健康安全风险,传统的增量式、补丁式治理已难以应对,根本出路在于推动健康支持体系实现“韧性嵌入”,即构建一个能主动适应压力、在冲击中维持核心功能并自我演进的系统性治理方案。这要求治理实践直接切入前文所述的“制度偏差削弱组织—组织弱化消耗资源—资源错配导向技术—技术隔离固化认知”的负向风险放大的联动演化机制,进行靶向破解与系统性重塑。具体而言,健康韧性在农村语境下应具象化为三个关键维度:一是风险

缓冲韧性,即应对突发健康事件与长期照护压力的能力;二是服务可及韧性,即在资源约束与空间分散条件下保障基本服务可靠获取的能力;三是文化适配韧性,即健康支持体系与乡土社会网络、价值观念及行为逻辑深度融合的能力。治理进路需围绕提升这三个维度的韧性展开,遵循机制破解、靶向发力、多维协同、动态演进的治理路径设计逻辑。

1. 理念重塑:双向认知调适与制度情境化嵌入

韧性再嵌的首要之举在于推动健康治理认知基础的转向,即从隐性的“城市中心主义”的标准化和效率化思维,转向“乡土中心主义”的实践视角,即基于乡土实际,因地制宜,形成可及、可落地和可持续的农村政策和实施路径。Stockton 等(2021)的循证研究表明:从地方到政策层面的整个卫生系统治理连续体的充分合作,是农村和偏远地区卫生服务提供的关键推动因素,特别是地方资源的充分动员与参与,以村居为网络基底的健康促进联盟的缔结。通过双向认知调适与制度情境化嵌入,实现理念与需求、政策与生活之间的有机衔接。其核心在于,将国家倡导的“以健康为中心”“预防为主、医养结合”等顶层理念,转化为契合农村老年人认知图式与生活逻辑的实践形态,进而激活基层健康服务体系的内生动力。为实现这一目标,需构建新时期“理念—认知—行为”的传导闭环。首先,在理念落地过程中,设立多层级的认知转换中介机制。让乡镇卫生院、村医、老年协会、家庭签约医生等乡土健康主体成为解释、转译与融合国家理念与地方性知识的关键节点。通过持续性、贴近生活的健康沟通(如结合农时、民俗的健康教育),将“预防为主”转化为老人可感知、可操作的日常实践(如季节性疾病防控、膳食微调),弥合理念传导中的“最后一公里”衰减。其次,健康治理策略需主动迎合并逐步重塑农村老年人的健康认知。一方面,识别并接纳其传统健康观念中的合理成分,将其作为建立信任、开展健康教育的起点;另一方面,通过渐进式、体验式的认知更新,例如组织低龄健康老人示范慢性病自我管理、利用村内公共空间开展康复互助活动等,帮助老人直观理解“定期体检”“规范用药”等现代健康行为的益处,推动认知从“疾病治疗”向“健康促进”缓慢而扎实的转变。最后,制度设计应体现对乡土韧

性资产的结构化吸纳。在“乡土中心主义”的指引下,政策工具箱应允许并鼓励基层利用村落固有的社会资本进行本土化创新。例如,将邻里互助探视纳入慢性病随访支持体系,赋予其一定的正式认可与资源衔接;鼓励以宗族、乡土人情为纽带组建健康互助小组,使其成为心理支持与应急响应的非正式单元;改造农村闲置公共空间为适老健康促进点,融合日常社交与健康监测功能。国家角色的重点从直接输送服务转向搭建平台、提供规范、赋能地方与整合资源,即作为元治理者推动形成“政府—社区—家庭—个人”多中心协同的健康治理网络。

2. 制度再嵌:构建协同治理的整合型政策体系

制度是固化认知并塑造组织与资源流向的关键节点,针对脱嵌闭环中制度架空组织的环节,制度再嵌需进行结构性改革,为韧性体系提供稳固的规则基础和资源保障。在制度优化层面,首要任务是构建风险预警与弹性配置的动态资源调适机制。为破解资源线性配置与需求非线性跃升的矛盾,建立县域层面的老龄化与健康资源动态监测体系,将资源分配与老龄化动态挂钩,设立应对超级老龄化的专项转移支付,允许地方在照护服务、适老改造、人力培训等领域灵活使用,实现从按人口数量或按既有服务利用配置到按健康风险配置资源与赋能的转变。其次,推动社会保障制度的乡土韧性化改造,在支付制度方面,尽快设计分层分类的长期护理保险农村参保方案,对集体经济较好地区,探索集体补助加个人缴费模式;对空心化严重地区,探索政府补贴为主与个人象征性缴费模式,核心是确保制度覆盖。服务设计包含喘息服务、家庭照护者培训与津贴等支持性内容,以增强家庭单元的照护韧性与经济安全;在服务制度方面,推行农村医防养融合签约服务包,将医保按人头打包支付给县域医共体,激励其将资源下沉至健康检查和慢性病管理,提升医养服务可及性,同时推行公共服务常住地登记制,确保流动老人平等享有权益。最后,创立乡土组织认证支持制度。为破解组织悬浮,由县级财政牵头,整合社会捐赠、集体资金,设立乡土健康养老基金,以小额项目制方式,支持自然村或村民小组发起互助照料、健康促进等微项目,同时建立对乡土健康互助组织的官方认证与能力建设支持体系,赋

予其合法身份并链接专业资源,使其从非正式网络转变为正式支持体系的有效延伸与补充。

3. 组织与资源再嵌:内外联动重建在地化服务增强网络

组织缺位与资源错配相互锁定,需将两者重新耦合,以新型组织形态高效匹配和撬动多元化资源,实现组织与资源的再嵌,摆脱组织消解资源的困境。一方面,培育“乡—村—户”的三级联动、虚实结合的韧性服务节点:以乡镇级综合服务中心整合卫生院、养老院、社工站功能,成为专业资源枢纽、培训基地和应急指挥中心;根据人口密度与闲置资源情况差异化建设村级/联村健康驿站数字联防网络基础单元节点。在人口聚集村,建设具备日间照料、康复活动、集体就餐功能的实体驿站;在高度空心化地区,推广流动驿站或依托农家院落建立邻里互助点,保障基本公共服务的可及性;为独居、高龄老人配备一键呼叫或无感监测等简易设备,与驿站、亲属、村医形成户级智慧联防单元,提升风险缓冲韧性。另一方面,实施乡土健康人力资本振兴计划,实施分层策略缓解人力资源短缺问题。对核心层的专业人才,实施县管乡用、乡聘村用的编制和待遇改革,扩大农村定向医学生、养老护理员培养规模,提供稳定补贴和职业发展路径,使其成为村居健康的守门人;对关键层的本土非专业健康促进骨干,激励低龄老人、留守妇女参与邻里互助,以线上健康管理教育平台和线下知识教育进行系统化培训,以微信群、站点和入户服务提供个别咨询与指导,培育乡村志愿健康管理员,建立时间银行或道德积分制度,用服务时长兑换未来服务或实物奖励,激活乡土社会资本;同时,强化资源优化配置的城乡协同与家庭联结,创新设计城乡家庭健康联结项目,鼓励在外子女通过数字平台参与父母的健康管理,例如远程监督用药、智能设备身体监测等。社区则可定期组织子女线上交流会或提供返乡探亲期间的健康护理技能速成培训,将离散的家庭支持重新嵌入乡土照护网络。此外,积极搭建城乡资源融合平台,推动城市医院与乡镇卫生院建立稳定的结对帮扶与远程诊疗关系,吸引城市退休医护人员、社工等以志愿服务或短期驻点形式支持农村;引导高校、企业将健康相关的社会实践、志愿服务与产品试点定向投放于农

村社区,将外部输入的资源精准滴灌至本地网络,形成内生韧性激活与外部资源赋能的良性互动。

4. 技术再嵌:发展乡土包容性数字健康赋能服务

技术再嵌的目标是使技术成为连接而非隔离的工具,破解技术强化隔离的负向循环,赋能前序路径。在技术融合层面,首先要推行“传统+数智”的混合服务模式。摒弃对复杂智慧平台的盲目追求,主推低成本、强交互、易维护的技术,例如利用广播、电视等传统媒介开设健康专栏;推广带大按键、语音功能的专用老年手机与固定应急呼叫器;为村医配备集成AI辅诊、慢性病管理功能的简易掌上设备,将数字工具与人工代办服务强制绑定,确保所有人被覆盖。其次,开展需求导向型的数字素养融合提升行动。将数字技能培训嵌入老年人高频、刚需的场景中,在卫生院、村卫生室开设手机就医小课堂,教老人如何挂号、查报告;结合亲情维系需求,教学视频通话,以老年人熟悉的乡村骨干或返乡青年作为培训主体,营造安全、信任的学习环境。最后,利用数字技术赋能韧性管理与评估。建设县级农村老年健康数字地图,动态汇聚高风险老人分布、服务设施状态、应急资源位置等信息,为精准施策和应急调度提供支持,同时探索通过物联网设备采集的匿名化行为数据,辅助评估社区社会隔离程度和异常事件风险,实现韧性状态的动态监测。

5. 韧性保障:构建跨路径风险防控动态调适机制

建立跨路径协同机制、风险防控和动态调适能力,确保治理体系自身具有韧性。一是构建“监测—评估—学习—调适”的动态循环。充分利用行政大数据,加强理论研究,政府牵头构建农村人口健康安全动态监测评估机制。确定并定期测量老年健康及其影响因素的关键指标,如老年抑郁发生率、应急响应平均时间、社区互助活动频率等。建立由政府部门、学术机构、社区代表组成的健康治理交流互动机制,定期评估成效。将成功的地方实践提炼为可推广的适应性工具包,并将失败教训作为制度优化的依据,使整个治理体系成为一个能够持续学习和进化的韧性生命体,从而真正经受住“十五五”乃至更长远时期

超级老龄化的健康压力测试。二是建立韧性再嵌新风险预估与防范机制。建立志愿者服务技能边界清单与责任保险,制定数据安全与隐私保护的乡村简易规范,强化基层干部的政策情境化解能力培训,防止政策执行错位,同时设立舆情与风险反馈通道,及时响应。

六、结 语

“十五五”时期是中国农村人口结构变迁与健康治理转型的关键阶段。面对快速逼近的超级老龄化社会,农村健康支持体系存在的系统脱嵌问题的影响日益凸显,已不再局限于个体或家庭的健康风险,而是可能演变为影响区域稳定与农村发展的系统性安全挑战。本研究基于“系统脱嵌—风险生成—韧性再嵌”的动态理论模型,系统阐释了制度滞后、组织真空、资源错配、技术排斥与认知偏差的脱嵌及相互交织,共同导致农村老年健康安全风险的生成与放大可能。

治理之道,在于靶向破解与系统性重塑,从根本上确立以乡土社会为本位的韧性治理范式,通过制度、组织、资源与技术的再嵌和韧性保障机制的建立,防控超级老龄化的农村社会的人口健康安全风险生成与递进,实现积极老龄化与健康老龄化。在这一治理理念和路径下,建议“十五五”时期在广大农村地区:一是尽快推动长期护理保险因地制宜分层落地和医保制度改革;二是在按照健康风险测算科学配置卫生资源和加大农村卫生资源投入的同时,充分利用在地化资源和促进城乡资源融合利用,增加农村老龄人口健康支持供给,如充分赋能正式非正式健康支持组织,构建新时期县乡村三级韧性服务节点网络和实施乡土健康人力资本振兴计划等;三是整合“医防养”资源,并推行农村适宜的“传统+数智”双路径健康治理技术应用。本研究在理论层面拓展了嵌入理论在健康治理领域的应用,构建了适用于中国乡土语境的分析框架。在实践层面,为“十五五”时期应对农村老龄化健康安全风险提供了系统性、前瞻性的治理思路。未来研究可进一步聚焦不同区域农村的异质性,开展韧性治理的实证检验与效果评估,推动政策设计更加精细化、地方化。在超级老龄化社会中,守住农村人

口健康安全的底线,为实现人口高质量发展、乡村振兴与共同富裕奠定坚实的健康基石。

参考文献:

1. Jonathan, C., R. Tomáš, et al. *Sustainable Health Financing with an Ageing Population: Implications of Different Revenue Raising Mechanisms and Policy Options*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019.
2. Hagedoorn, J. Understanding the Cross-level Embeddedness of Interfirm Partnership Formation. *Academy of Management Review*, 2006, 31(3):670—680.
3. Stockton, D. A., C. Fowler, et al. World Health Organization Building Blocks in Rural Community Health Services: An Integrative Review. *Health Science Reports*, 2021, 4(2):254—270.
4. Wan, X., Y. Ao, et al. Digital Health Services and Rural Healthcare Access: Evidence from China. *Health Policy and Technology*, 2026, 15(1): 101123.
5. Zhang, K., X. Cheng, et al. The Digital Divide of Older People in Communities: Urban-Rural, Gender, and Health Disparities and Inequities. *Health & Social Care in the Community*, 2025, 1:1—10.
6. Zukin, S., and P. DiMaggio. *Structures of Capital: The Social Organization of the Economy*. Cambridge University Press, 1990.
7. [英]波兰尼著,冯钢、刘阳译:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,浙江人民出版社 2007 年版。
8. [美]格兰诺维特著,罗家德译:《镶嵌:社会网与经济行动》,社会科学文献出版社 2015 年版。
9. 陈柏霖:《老龄化社会背景下社区健康传播的价值与发展路径》,《青年记者》2022 年第 2 期。
10. 陈功、刘菊芬等:《安全与人口安全:概念的发展与讨论》,《市场与人口分析》2005 年第 2 期。
11. 陈华帅、马伟:《数字乡村发展与农村老年人健康水平》,《华南农业大学学报(社会科学版)》2024 年第 4 期。
12. 江生忠、郭修琪等:《社会养老保险对老年人身心健康的影响研究》,《江西财经大学学报》2024 年第 2 期。
13. 李静、王小凤:《“积极”何以可能? 健康、保障与退休老年人的社会参与困境》,《人口与社会》2025 年第 6 期。

14. 李逸超、米红:《中国老年人口失能预期寿命的城乡差异——基于贝叶斯方法的再估计》,《中国人口科学》2025 年第 4 期。
 15. 刘慧君、吴鹏:《中国健康老龄化水平的动态演进及服务效能驱动研究》,《人口学刊》2025 年第 1 期。
 16. 吕佩安:《数字政府大语言模型应用的风险及其调适路径——以风险社会理论为视角》,《湖南社会科学》2025 年第 4 期。
 17. 庞瑞芝、李倩楠:《健康中国背景下的“看病贵”与政府支出——基于资源配置结构性失衡视角的分析》,《西安交通大学学报(社会科学版)》2024 年第 2 期。
 18. 彭希哲:《探寻全生命周期主动健康治理的“中国方案”》,《探索与争鸣》2025 年第 6 期。
 19. 浦雪、翟铁民:《我国城乡老年人慢性病共病与失能问题的实证研究》,《现代预防医学》2025 年第 20 期。
 20. 石人炳、虎经博:《未来农村人口老龄化:迁出与回流》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2024 年第 5 期。
 21. 谢永飞、刘铁锋:《健康老龄化视角下的老年数字鸿沟:成因与治理》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》2024 年第 5 期。
 22. 许昕、赵媛、周建芳:《中国县域人口老龄化格局特征与作用机制》,《地理研究》2025 年第 6 期。
 23. 薛文忠、李长振、王震:《老龄化背景下老年人主动健康促进行动方案构建与实施策略》,《广州体育学院学报》2022 年第 4 期。
 24. 原新、陈功等:《“守住人口安全底线,实现人口高质量发展”学术笔谈》,《人口与社会》2025 年第 1 期。
 25. 翟振武、明艳:《定义“人口安全”》,《人口研究》2005 年第 3 期。
 26. 詹承豫、高叶、徐明婧:《系统韧性:一个统筹发展与安全的核心理念》,《广州大学学报(社会科学版)》2022 年第 4 期。
 27. 张雨薇、武晋、李小龙:《村医与国家:从深度嵌入到偏差嵌入》,《湖北社会科学》2020 年第 4 期。
 28. 周建芳、陈燕儿、林洁:《OECD 国家人口老龄化水平与卫生资源配置的门槛效应研究》,《南京医科大学学报(社会科学版)》2024 年第 5 期。
- 作者简介:周建芳,南京邮电大学人口研究院教授(南京 210042)。

[责任编辑:唐文浩]